TAKILAN VAKAYI KURTAR™ · BONUS 2

Acil Kontrol Durumları: Kırık Braket, Batan Tel, Kırılan Aparey

Kontrol arasında gelen 25 acil durum: değerlendirme, protokol ve hastaya söylenecek hazır metin.

İçindekiler

Acil durumda ilk 60 saniye

25 durumun dizini

1 · Braket, tüp ve bant

2 · Tel ve ligatür

3 · Ağrı ve yumuşak doku

4 · Mini vida

5 · Aparey

6 · Pekiştirme ve plak

7 · Travma ve yutma

Acil kayıt formu

BAŞLARKEN

Acil durumda ilk 60 saniye

Her acil durumda aynı sıra: güvenlik, neden, çözüm, kayıt.

1. **Güvenlik:** Solunum, kanama, yutma veya travma var mı? Varsa önce o.
2. **Ne kırıldı, ne battı?** Parçayı bulun ve ağızda serbest parça kalmadığından emin olun.
3. **Hasta güvende mi?** Batan, sürtünen veya serbest parçayı giderin.
4. **Neden?** Kapanış, gıda, yapıştırma, aparey tasarımı. Not edin.
5. **Karar:** şimdi düzelt, sonraki kontrole bırak veya yönlendir.
6. **Kayıt:** Tarih, durum, neden, yapılan işlem ve hastaya verilen bilgi.

Hemen yönlendirme gerektiren durumlar

- Yutma veya aspirasyon şüphesiyle birlikte öksürük, nefes darlığı veya yutma güçlüğü
- Diş travması: yerinden çıkma, kırık, çene travması
- Yayılan şişlik, ateş, akıntı
- Durdurulamayan kanama

Hastaya giden metinler hakkında

Metinlerdeki **[Hasta adı]**, **[Klinik adı]** ve **[Randevu tarihi]** alanlarını kendi bilgilerinizle doldurun. Metinler bilgilendirme amaçlıdır; kliniğinizin kullandığı iletişim kanalıyla ve kendi üslubunuzla gönderin.

DİZİN

25 durumun dizini

Durumu bulun, numaraya gidin.

NO	DURUM	GRUP
01	Ön dişte braket düşmesi	Braket, tüp ve bant
02	Arka dişte braket düşmesi	Braket, tüp ve bant
03	Molar tüp veya bant gevşemesi	Braket, tüp ve bant
04	Distal tel ucu yanağa batıyor	Tel ve ligatür
05	Ark telinin tüpten çıkması	Tel ve ligatür
06	Kırık ark teli	Tel ve ligatür
07	Ligatür teli ucu batıyor	Tel ve ligatür
08	Elastik ligatür veya zincir kaybı	Tel ve ligatür
09	Açık yayın yer değiştirmesi	Tel ve ligatür
10	İlk günlerdeki ağrı ve hassasiyet	Ağrı ve yumuşak doku
11	Yanak veya dudakta yara	Ağrı ve yumuşak doku
12	Mini vida çevresinde iritasyon	Mini vida
13	Mini vidada mobilite veya düşme	Mini vida
14	RME vidası gevşedi veya bant ayrıldı	Aparey
15	Transpalatal bar kopması	Aparey
16	Nance düğmesinin dokuya gömülmesi	Aparey
17	Hareketli fonksiyonel aparey kırığı	Aparey
18	Sabit fonksiyonel aparey bağlantı kopması	Aparey
19	Yüz maskesinde cilt tahrişi veya bağlantı sorunu	Aparey

NO	DURUM	GRUP
20	Sabit lingual pekiştirme kopması	Pekiştirme ve plak
21	Şeffaf plak veya Essix kırıldı veya kayboldu	Pekiştirme ve plak
22	Hawley plak kırıldı	Pekiştirme ve plak
23	Şeffaf plak tedavisinde ataçman düştü	Pekiştirme ve plak
24	Braketli hastada diş travması	Travma ve yutma
25	Yutulan veya kaybolan parça şüphesi	Travma ve yutma

GRUP 01

Braket, tüp ve bant

3 durum

DURUM 01 Ön dişte braket düşmesi

Değerlendirme: Braket telde mi asılı, tamamen çıktı mı? Diş yüzeyinde hasar var mı? Düşme kapanış temasından mı?

PROTOKOL

1. Teli ve braketi kontrol edin; tel batmıyorsa hasta güvende.
2. Düşme nedenini not edin: kapanış, gıda, yapıştırma yüzeyi.
3. Yeniden yapıştırın veya bir sonraki kontrole planlayın.
4. Aynı diş tekrar düşüyorsa kapanış temasını kontrol edin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], dişinizdeki braketin ayrılması acil bir durum değildir. Braket telde kalabilir; batmıyorsa dokunmayın. [Klinik adı] olarak [Randevu tarihi] tarihindeki kontrolünüzde yeniden yapıştıracağız. Sert ve yapışkan gıdalardan kaçının.

Ne zaman acil: Diş kırığı veya travma eşlik ediyorsa aynı gün değerlendirin.

DURUM 02 Arka dişte braket düşmesi

Değerlendirme: Premolar braketi telde dönüyor mu, yanağa sürtünüyor mu?

PROTOKOL

1. Dönen braket yanağa sürtünüyorsa geçici olarak sabitleyin veya çıkarın.
2. Teli kontrol edin; distal uç batıyor mu?
3. Yeniden yapıştırmayı planlayın.
4. Kapanış temasını kontrol edin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], arka dişinizdeki braket ayrılmış olabilir. Yanağınıza sürtünüyorsa ortodontik mumu üzerine koyun. [Randevu tarihi] tarihindeki kontrolde düzelteceğiz.

Ne zaman acil: Yanakta derin yara veya yutma riski varsa erken randevu.

DURUM 03

Molar tüp veya bant gevşemesi

Değerlendirme: Bant dişin üzerinde hareket ediyor mu? Siman altında gıda birikimi var mı?

PROTOKOL

1. Bantı çıkarın, dişi temizleyin ve yüzeyi değerlendirin.
2. Yeniden simante edin veya yeni bant seçin.
3. Bağlı aparey varsa (TPA, RME) bütünlüğünü kontrol edin.
4. Gevşemeyi günlüğe yazın.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], arka dişinizdeki halka gevşemiş olabilir. Gıda birikmemesi için bölgeyi dikkatlice temizleyin. Randevunuzu öne almanız önerilir: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Bant tamamen çıkmış ve aparey ağızda serbest kalmışsa aynı gün.

GRUP 02

Tel ve ligatür

6 durum

DURUM 04 Distal tel ucu yanağa batıyor

Değerlendirme: Tel tüpten ne kadar uzun? Diş hareketiyle mi uzadı (boşluk kapandıkça)?

PROTOKOL

1. Fazla teli kesin; ucu köreltin veya büküp kapatın.
2. Kesilen parçanın ağızda kalmadığından emin olun.
3. Yanaktaki yarayı kontrol edin.
4. Boşluk kapanıyorsa bir sonraki kontrolde tekrar bakmayı not edin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], telin ucu yanağınıza batıyorsa ortodontik mumu üzerine koyun. Teli kendiniz kesmeyin. [Klinik adı] olarak [Randevu tarihi] tarihinde düzelteceğiz.

Ne zaman acil: Tel dokuya gömülmüş ve kanama varsa erken randevu.

DURUM 05 Ark telinin tüpten çıkması

Değerlendirme: Tel tüpten çıkmış, serbest uç dokuya batıyor mu?

PROTOKOL

1. Teli tüpe yeniden yerleştirin.
2. Çıkış nedenini kontrol edin: tel kısa mı, aşırı aktivasyon mu?
3. Gerekirse teli değiştirin.
4. Serbest uç varsa kapatın.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], tel arka dişteki yuvasından çıkmış olabilir. Batıyorsa mum kullanın ve teli çekmeyin. Randevunuz: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Serbest tel yaralanmaya yol açıyorsa erken randevu.

DURUM 06 Kırık ark teli

Değerlendirme: Tel nerede kırık? Kırık parça hareketli mi, yutma riski var mı?

PROTOKOL

1. Kırık parçaları çıkarın.
2. Teli değiştirin.
3. Kırık noktasını not edin; tekrar ediyorsa kapanış teması veya yorgunluk.
4. Plana göre diş konumunu kontrol edin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], telinizde kırık olabilir. Parçalar hareket ediyorsa çıkarmaya çalışmayın; mum kullanın ve randevunuzu öne alın: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Parça kaybolduysa ve yutma şüphesi varsa Durum 25'e bakın.

DURUM 07 Ligatür teli ucu batıyor

Değerlendirme: Ligatür ucu dudak veya yanağa doğru mu dönmüş?

PROTOKOL

1. Ucu kısaltın ve braket altına doğru katlayın.
2. Diğer ligatürleri kontrol edin.
3. Yarayı kontrol edin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], ince bir tel ucu dudağınıza batıyorsa üzerine mum koyun. Kontrolde düzelteceğiz: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Genellikle acil değildir.

DURUM 08 Elastik ligatür veya zincir kaybı

Değerlendirme: Hangi dişte ligatür yok? Tel yuvadan çıkmış mı? Boşluk açıldı mı?

PROTOKOL

1. Eksik ligatürleri yenileyin.
2. Zincir kaybında boşluk durumunu ölçün.
3. Kayıp sıksa gıda alışkanlığını konuşun.

HASTAYA SÖYLENECEK

> *Sayın [Hasta adı], dişlerinizdeki küçük lastiklerden biri düşmüş olabilir. Bu acil bir durum değildir. [Randevu tarihi] tarihindeki kontrolde yenileyeceğiz.*

Ne zaman acil: Genellikle acil değildir.

DURUM 09 Açık yayın yer değiştirmesi

Değerlendirme: Yay kaymış, dişeti veya yanağa baskı yapıyor mu?

PROTOKOL

1. Yayı yerine alın veya çıkarın.
2. Yer açma amacını kontrol edin; açılan yer korunuyor mu?
3. Yayın stoplarını kontrol edin.

HASTAYA SÖYLENECEK

> *Sayın [Hasta adı], dişleriniz arasındaki yay yerinden kaymış olabilir. Rahatsızlık varsa mum kullanın. Randevunuz: [Randevu tarihi].*

Ne zaman acil: Dişetine gömülme ve kanama varsa erken randevu.

GRUP 03

Ağrı ve yumuşak doku

2 durum

DURUM 10 İlk günlerdeki ağrı ve hassasiyet

Değerlendirme: Yeni aktivasyon mu? Ağrı tek dişte mi, yaygın mı?

PROTOKOL

1. Beklenen hassasiyeti normal olandan ayırın.
2. Tek dişte şiddetli ağrıda erken temas ve pulpa durumunu kontrol edin.
3. Hastaya yumuşak beslenme ve ağız hijyeni bilgisi verin.
4. Ağrı kesici gerekirse hekim kararıyla; doz bu materyalde verilmez.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], aktivasyondan sonraki ilk günlerde dişlerinizde hassasiyet olması beklenebilir. Yumuşak gıdalar tercih edin. Ağrı birkaç gün içinde azalmıyor veya tek bir dişte artıyorsa randevunuzu öne alın.

Ne zaman acil: Şişlik, ateş veya tek dişte artan ağrı varsa aynı gün değerlendirin.

DURUM 11 Yanak veya dudakta yara

Değerlendirme: Yara hangi apareyin karşısında? Kenarı keskin bir parça var mı?

PROTOKOL

1. Nedeni bulun ve giderin (keskin uç, kanca, braket kanadı).
2. Hastaya mum kullanımını gösterin.
3. Yarayı izleyin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], ağzınızdaki yara apareyin sürtünmesinden olabilir. Sürtünen yerin üzerine mum koyun. Yara birkaç gün içinde iyileşmezse kontrolü öne alın.

Ne zaman acil: İyileşmeyen veya büyüyen yara varsa ilgili uzman değerlendirmesi.

GRUP 04

Mini vida

2 durum

DURUM 12 Mini vida çevresinde iritasyon

Değerlendirme: Çevrede kızarıklık, şişlik veya akıntı var mı? Temizlik yapılıyor mu?

PROTOKOL

1. Bölgeyi temizleyin ve dokuyu değerlendirin.
2. Hijyen talimatını yenileyin.
3. Yük altındaysa vidanın stabilitesini kontrol edin.
4. Durumu kaydedin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], vidanın çevresindeki dokuyu yumuşak bir fırçayla dikkatlice temizleyin. Şişlik veya akıntı artarsa randevunuzu öne alın.

Ne zaman acil: Yayılan şişlik, ateş veya akıntıda aynı gün değerlendirme ve gerekiyorsa yönlendirme.

DURUM 13 Mini vidada mobilite veya düşme

Değerlendirme: Vida mobil mi, düştü mü? Düşen vida bulundu mu?

PROTOKOL

1. Mobil vidayı yüklemeyin.
2. Düştüyse bölgeyi kontrol edin; vidanın kaybolmadığından emin olun.
3. Mekaniği vidasız güvenli duruma getirin.
4. Yeniden yerleştirme kararını ve yeni bölgeyi planlayın.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], ağzınızdaki küçük vida düşmüş veya gevşemiş olabilir. Bulduysanız saklayın ve kontrolde getirin. Randevunuzu öne alın: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Vida kaybolduysa ve yutma şüphesi varsa Durum 25'e bakın.

GRUP 05

Aparey

6 durum

DURUM 14 RME vidası gevşedi veya bant ayrıldı

Değerlendirme: Aparey hareket ediyor mu? Vida dönüyor mu? Aktivasyon kaydı?

PROTOKOL

1. Apareyi ve bantları kontrol edin.
2. Gerekirse apareyi çıkarıp yeniden simante edin.
3. Aktivasyonu durdurun ve kaydı güncelleyin.
4. Genişleme durumunu ölçün.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], damaktaki genişletme apareyi gevşemiş olabilir. Vidayı çevirmeye ara verin. Randevunuzu öne alın: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Aparey ağızda serbest kaldıysa aynı gün.

DURUM 15 Transpalatal bar kopması

Değerlendirme: Kopma noktası lehim mi, bant mı? Bar serbest mi?

PROTOKOL

1. Serbest parçayı çıkarın.
2. Ankraj ihtiyacını değerlendirin; geçici çözüm planlayın.
3. Apareyi yenileyin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], damaktaki bar ayrılmış olabilir. Parça hareketliyse dikkatlice çıkarın veya mum kullanın ve randevunuzu öne alın.

Ne zaman acil: Parça serbest ve yutma riski varsa aynı gün.

DURUM 16

Nance düğmesinin dokuya gömülmesi

Değerlendirme: Damak mukozasında iz, ülser veya iltihap var mı?

PROTOKOL

1. Apareyi dokudan uzaklaştırın veya çıkarın.
2. Dokunun iyileşmesini izleyin.
3. Hijyen talimatını yenileyin.
4. Ankraj için geçici çözüm planlayın.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], damağınızdaki aparey dokuya baskı yapıyor olabilir. Bölgeyi temiz tutun ve kontrolde değerlendirelim: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: İyileşmeyen ülserde ilgili uzman.

DURUM 17

Hareketli fonksiyonel aparey kırığı

Değerlendirme: Kırık nerede? Aparey hâlâ takılabiliyor mu?

PROTOKOL

1. Kırığı değerlendirin; onarım veya yenileme kararı verin.
2. Aparey takılamıyorsa tedavinin hangi aşamasında olduğunu not edin.
3. Hastaya kırık apareyi takmamasını söyleyin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], apareyiniz kırılmışsa takmayın ve parçaları saklayın. Kontrolde getirin: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Genellikle acil değildir; tedavinin aksamaması için kısa sürede onarım.

DURUM 18 Sabit fonksiyonel aparey bağlantı kopması

Değerlendirme: Bağlantı tamamen mi koptu? Aparey ağızda serbest mi?

PROTOKOL

1. Serbest parçaları alın.
2. Bağlantıyı yenileyin.
3. Ağız açma hareketini kontrol edin.
4. Tekrarlayan kopmaları kaydedin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], dişlerinizdeki sabit apareyin bir bağlantısı ayrılmış olabilir. Ağzınızı çok açmayın ve randevunuzu öne alın: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Parça serbestse aynı gün.

DURUM 19 Yüz maskesinde cilt tahrişi veya bağlantı sorunu

Değerlendirme: Ciltte kızarıklık veya yara var mı? Kancalar ağız içinde sağlam mı?

PROTOKOL

1. Basınç noktalarını düzenleyin.
2. Ağız içi bağlantıları kontrol edin.
3. Kullanım süresini ve düzenini hastayla yeniden konuşun.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], maskenin temas ettiği yerlerde kızarıklık varsa kontrolde düzenleyeceğiz. Ciltte yara oluşursa maskeyi takmaya ara verin ve randevunuzu öne alın.

Ne zaman acil: Ciltte yara veya enfeksiyon belirtisinde ilgili hekim.

GRUP 06

Pekiştirme ve plak

4 durum

DURUM 20 Sabit lingual pekiştirme kopması

Değerlendirme: Hangi dişte kopma var? Dişler hareket etti mi?

PROTOKOL

1. Kopmayı ve diş konumunu kaydedin.
2. Onarın veya yenileyin.
3. Nüks varsa miktarını ölçün.
4. Pekiştirme planını gözden geçirin (Rehber 2).

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], dişlerinizin arkasındaki ince telin bir ucu ayrılmış olabilir. Dişlerin kaymaması için kontrolü öne almanız önerilir: [Randevu tarihi]. Varsa şeffaf plağınızı takmaya devam edin.

Ne zaman acil: Batma ve yara varsa erken randevu.

DURUM 21 Şeffaf plak veya Essix kırıldı veya kayboldu

Değerlendirme: Plak ne zamandan beri kullanılmıyor? Dişler kaydı mı?

PROTOKOL

1. Yeni plak için ölçü veya tarama planlayın.
2. Diş konumunu kontrol edin.
3. Kayıp süresini kaydedin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], plağınızı kaybettiyseniz veya kırıldıysa dişlerin kaymaması için kısa sürede yeni plak gerekir. Randevunuzu öne alın: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Genellikle acil değildir; gecikme nükse yol açabilir.

DURUM 22 Hawley plak kırıldı

Değerlendirme: Kırık akrilikte mi, telde mi? Plak hâlâ oturuyor mu?

PROTOKOL

1. Onarım veya yenileme kararı verin.
2. Oturmayı kontrol edin.
3. Kırık parçanın dokuya batmadığından emin olun.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], plağınız kırıldıysa takmayın ve parçaları saklayın. Kontrolde getirin: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Genellikle acil değildir.

DURUM 23 Şeffaf plak tedavisinde ataçman düştü

Değerlendirme: Hangi ataçman? Plak oturuyor mu?

PROTOKOL

1. Ataçmanı şablonla yenileyin.
2. Oturmayı kontrol edin.
3. Hastaya plak çıkarma tekniğini gösterin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], dişinizdeki küçük çıkıntılardan biri düşmüş olabilir. Plağınızı takmaya devam edin; kontrolde yenileyeceğiz: [Randevu tarihi].

Ne zaman acil: Genellikle acil değildir.

GRUP 07

Travma ve yutma

2 durum

DURUM 24 Braketli hastada diş travması

Değerlendirme: Hangi dişler etkilendi? Mobilite, kırık, yer değiştirme var mı?

PROTOKOL

1. Dişleri, kemiği ve yumuşak dokuyu değerlendirin.
2. Radyografi alın.
3. Aktif kuvvetleri travmalı dişten kaldırın.
4. Canlılığı belgeleyin ve izleme planı yapın (Rehber 4 · Travma ve Ankiloz).
5. Gerekiyorsa ilgili uzmana yönlendirin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], dişlerinize darbe aldıysanız aynı gün değerlendirilmeniz gerekir. Yerinden çıkan bir diş veya parça varsa saklayın ve hemen başvurun.

Ne zaman acil: Dişin yerinden çıkması, kırık veya çene travmasında aynı gün; gerekirse acil hizmet.

DURUM 25 Yutulan veya kaybolan parça şüphesi

Değerlendirme: Hangi parça eksik? Hastada öksürük, nefes darlığı, yutma güçlüğü var mı?

PROTOKOL

1. Ağız içini dikkatle kontrol edin.
2. Solunum belirtisi varsa hastayı derhal acil tıbbi değerlendirmeye yönlendirin.
3. Belirti yoksa durumu kaydedin ve hekim kararıyla tıbbi değerlendirmeyi planlayın.
4. Parçanın neden düştüğünü belirleyin.

HASTAYA SÖYLENECEK

Sayın [Hasta adı], apareyinizden bir parça yuttuğunuzu düşünüyorsanız ve öksürük, nefes darlığı veya yutma güçlüğü varsa hemen en yakın acil servise başvurun. Belirti yoksa randevunuzu öne alın; nasıl ilerleneceğine birlikte karar verelim.

Ne zaman acil: Solunum belirtisi her zaman acildir.

FORM

Acil kayıt formu

Her acil durum için bir form. Çoğaltarak kullanın.

Acil kayıt 1

Hasta

Tarih

Durum no ve adı

Ne oldu (hastanın anlatımı)

Bulgu

Olası neden

Yapılan işlem

Hastaya verilen bilgi

Tekrar eden durum mu?

Sonraki kontrol

Acil kayıt 2

Hasta

Tarih

Durum no ve adı

Ne oldu (hastanın anlatımı)

Bulgu

Olası neden

Yapılan işlem

Hastaya verilen bilgi

Tekrar eden durum mu?

Sonraki kontrol

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Acil durum tekrar ediyorsa **Vaka Günlüğü**'ndeki kök neden analizini doldurun. Mekanik bir neden görüyorsanız **Mekanik Sorun Giderme Atlası**'nı, travma için **Rehber 4 · Travma ve Ankiloz**'u açın.